

Национальная скрининговая программа: реализация скрининговых осмотров по раннему выявлению рака молочной железы, шейки матки, колоректального рака

Нургазиев К.Ш., Кулкаева Г.У., Жылкайдарова А.Ж.

Министерство здравоохранения РК, Казахский НИИ онкологии и радиологии

Актуальность

Смертность от злокачественных новообразований занимает второе место в структуре общей смертности населения Республики Казахстан. Мероприятия, направленные на раннее выявление онкологических заболеваний (скрининговые исследования), а также обеспечение химиопрепаратами, укрепление материально-технической базы медицинских организаций позволили снизить показатель смертности от злокачественных новообразований с 122,6 на 100 тысяч населения в 2005 году до 103,9 в 2010 году (данные КазНИИОиР). За этот же период отмечается снижение показателя заболеваемости злокачественными новообразованиями — со 192,5 на 100 тыс. населения в 2005 году до 181,2 в 2010 году. При этом самый высокий уровень данного показателя стабильно регистрируется в регионах, где развита промышленность — в Северо-Казахстанской (282,6), Восточно-Казахстанской (272,3) и Павлодарской (270,4) областях.

Реализуемые в Республике с 2008 года скрининговые исследования по раннему выявлению рака молочной железы и рака шейки матки позволили выявить за три года и 3 месяца 2011 года 1950 случаев рака молочной железы (или 0,15% из числа осмотренных, европейский стандарт — 0,2-0,3%) и 509 случаев рака шейки матки (0,03%, что соответствует европейскому стандарту проведения скрининговых осмотров). В то же время в регионах с высокой онкологической заболеваемостью (Восточно-Казахстанская, Павлодарская области) уровень выявления злокачественных образований молочной железы и шейки матки во время скрининговых осмотров был ниже республиканских показателей.

Государственной программой развития здравоохранения «Саламатты Қазақстан» на 2011-2015 гг. предусмотрено дальнейшее расширение Национальной скрининговой программы за счет увеличения перечня нозологий с ежегодным охватом не менее 30% от общей численности населения, подлежащего скрининговым осмотрам, разработкой и внедрением целевых индикаторов, отражающих эффективность проводимых мероприятий по профилактике, ранней диагностике злокачественных новообразований, выявления лиц с предопухолевой патологией и факторами риска, основанных на доказательной медицине.

Материалы и методы

В работе представлены результаты скрининговых исследований за 6 месяцев 2011 года.

За первое полугодие 2011 года маммографические исследования проведены 156 623 женщинам в возрасте 50, 52, 54, 56, 58 и 60 лет, что составило 35,6% от запланированного объема.

Наибольший процент охвата от запланированного количества женщин отмечен в Павлодарской (обследовано

Жұмыста сүт безі, жатыр мойны мен колоректалды рагын анықтау бойынша 2011 жылдың 6 айында Ұлттық скринингтік бағдарламасын жүзеге асырудың қорытындылары ұсынылған. Сүт безі рагын анықтау бойынша мақсатты топтың 156 623 әйел азаматы қаралып, 75 ауру жағдайы анықталған (тексерілгендердің 0,05%). Жатыр мойнының қатерлі ісігіне 218 830 әйел қаралып, 86-сында ЖМР анықталды, бұл 0,04% үлесін құрады. Колоректалды скрининг бойынша гамокульт тестпен тексерілуі тиесілі азаматтардың 1 222 707-сі қаралды (әйелдер мен ер адамдар). Рак ауруы 1 адамда, рак алды 17 адамда анықталды. Ұлттық скрининг бағдарламасын жетілдіру бойынша ұсыныстар да жазылған.

В работе представлены результаты реализации Национальной скрининговой программы по раннему выявлению рака молочной железы, шейки матки, колоректального рака за 6 месяцев 2011 года. По скринингу РМЖ осмотрено 156 623 женщин целевой группы, выявлено 75 случаев РМЖ (0,05% от числа обследованных). По скринингу РШМ осмотрено 218 830 женщин, РШМ установлен у 86 женщин, что составляет 0,04%. По колоректальному скринингу гемокульт тест проведен 1 222 707 мужчинам и женщинам целевой группы, рак был выявлен у 1 пациента, предрак — у 17. Представлены предложения по дальнейшему совершенствованию Национальной скрининговой программы.

The results of the National Cancer Screening Program for 6 months 2011 are presented. Breast cancer screening involved 156 623 women from target group. 75 cases of a breast cancer (0,05 %) are detected. Cervical cancer screening involved 218 830 women, 86 women (0,04%) had diagnosis of cancer. Colorectal screening by haemocult-test involved 218 830 patients. The 1 case of colorectal cancer and 17 cases of precancerous lesions are detected. Offers for further improvement of the National Cancer Screening Program are suggested.

7276 женщин — 52,7%), в Западно-Казахстанской (8316 или 51,3%) областях и г.Астана (4862 и 50,3%), наименьший — в Алматинской (12079 — 25,7%), Мангистауской (2168 — 22,1%), Южно-Казахстанской (17976 — 29,5%) областях.

За первое полугодие 2011 года в рамках скрининга на раннее выявление предопухолевых и злокачественных новообразований шейки матки проведено цитологическое исследование мазков 218830 женщинам в возрасте 30, 35, 40, 45, 50, 55 и 60 лет, что составило 42,9% от числа

запланированного контингента. Наибольший процент охвата цитологическим скринингом отмечен в Алматинской (88,5%), Западно-Казахстанской (65,9%), г.Астана (57%) и г.Алматы (55,4%), менее трети от плана – в Атырауской (23,2%), Южно-Казахстанской (28,9%), Кызылординской (31,3%), Мангистауской (31,5%), Восточно-Казахстанской (31,6%) областях.

В рамках скрининга на раннее выявление предопухолевых и злокачественных новообразований толстой и прямой кишки проведен гемокульт-тест (тест на скрытую кровь) 1222707 мужчинам и женщинам в возрасте 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 и 70 лет. По данным 7 регионов охват составил 16% от числа запланированного контингента – от 6,5% в Акмолинской области до 23,9% в г.Астана.

Результаты. Скрининг на раннее выявление доброкачественных и злокачественных новообразований молочной железы.

Рак молочной железы (РМЖ) выявлен в 75 случаях, что составило 0,04% от числа обследований (таблица 1). Самый высокий процент выявления РМЖ в Южно-Казахстанской (0,1%), Западно-Казахстанской (0,1%) областях. Ни одного случая рака за 6 месяцев не выявлено в Акмолинской, Атырауской, Карагандинской и Кызылординской областях.

На рисунках 1 и 2 представлены распределение выявленного РМЖ в зависимости от размеров опухолевого узла – до 1 см и более 1 см.

Таблица 1 - Информация по маммографическому обследованию с целью выявления рака молочной железы (РМЖ) за 6 месяцев 2011 года.

№	Регионы	План на 2011 г.	Выполнено		РМЖ	
			абс.	%	абс.	%
1	Акмолинская	22448	7337	32,7	4	0,05
2	Актыбинская	20570	9925	48,2	-	-
3	Алматинская	47000	12079	25,7	4	0,03
4	Атырауская	11627	2063	17,7	-	-
5	ВКО	41176	11629	28,2	7	0,06
6	Жамбылская	23150	8615	37,2	3	0,03
7	ЗКО	16234	8316	51,3	8	0,1
8	Карагандинская	52772	17591	33,3	-	-
9	Кызылординская	13131	4546	34,6	-	-
10	Костанайская	27 551	11149	40,5	17	0,15
11	Мангистауская	9816	2168	22,1	1	0,04
12	Павлодарская	13842	7276	52,7	2	0,03
13	СКО	20496	9116	44,5	3	0,03
14	ЮКО	61109	17976	29,5	17	0,1
15	г. Алматы	49294	21975	44,5	7	0,03
16	г. Астана	9662	4862	50,3	2	0,04
Итого		4 3 9 838	1 5 6 623	35,6	75	0,04

РМЖ менее 1 см чаще выявлялся в Западно-Казахстанской (0,06%), Южно-Казахстанской (0,05%) областях и г.Астана (0,04%), более 1 см – в Костанайской области (0,14%). В целом по стране выявление РМЖ до 1 см составило 41,3% (европейский стандарт 60-80%). Наибольший процент малой формы РМЖ (до 1 см) выявлен в г.Астана (100%), Северо-Казахстанской (66,7%), Жамбылской (66,7%) областях.

Скрининг на раннее выявление предопухолевых и злокачественных новообразований шейки матки.

На рисунке 3 представлено распределение выявленных доброкачественных заболеваний молочной железы в разрезе по регионам. Высокий уровень выявления доброка-

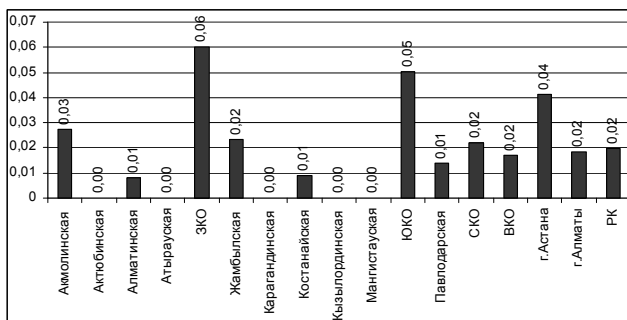


Рисунок 1. Результаты маммографических исследований за 6 месяцев 2011 года – опухолевый узел до 1 см (%)

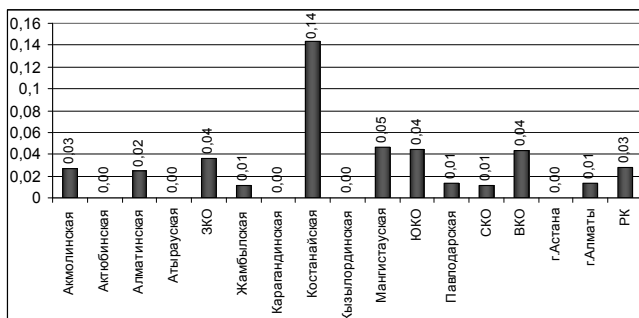


Рисунок 2. Результаты маммографических исследований за 6 месяцев 2011 года – опухолевый узел до 1 см (%)

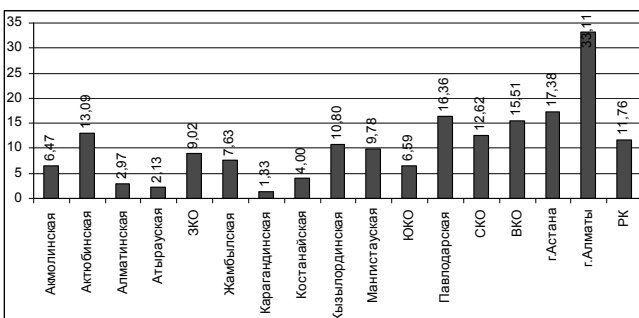


Рисунок 3. Процент выявленных доброкачественных заболеваний молочной железы по результатам маммографических исследований за 6 месяцев 2011 года.

чественной патологии отмечен в г.Алматы (33,1% от числа обследований), г.Астана (17,4%), Павлодарской (16,4%), Восточно-Казахстанской (15,5%), Актыбинской (13,1%), Северо-Казахстанской (12,6%) областях, низкий уровень – в Карагандинской (1,3%), Атырауской (2,1%), Алматинской (3%) областях при среднестрановом уровне 11,8% от числа проведенных маммографий (18417 из 156623).

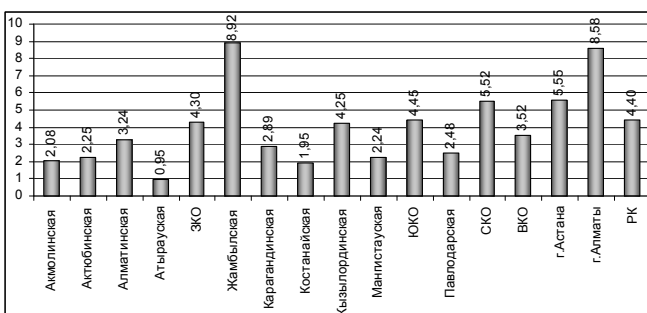


Рисунок 4. Процент больных с заболеваниями шейки матки по результатам 6 месяцев 2011 года в разрезе по регионам.

Как представлено на рисунке 4, у 4,4% обследованных женщин выявлена различная патология шейки матки.

Наиболее чаще патология выявлялась в Жамбылской (8,9%) области и г.Алматы (8,6%), реже всего – в Атырауской (1%), Костанайской (2%), Акмолинской (2,1%), Мангистауской (2,2%), Актыбинской (2,3%) и Павлодарской

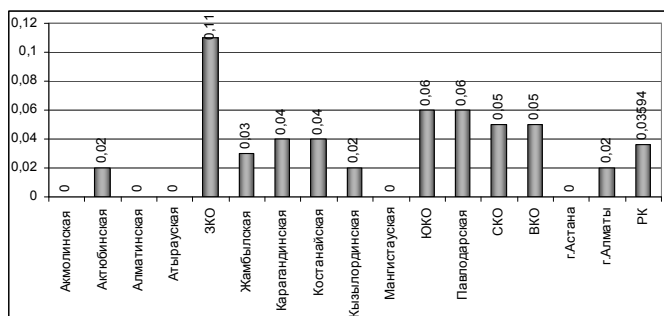


Рисунок 5. Процент больных с выявленным раком шейки матки по результатам 6 месяцев 2011 года в разрезе по регионам.

(2,5%) областях.

Рак шейки матки (РШМ) выявлен в 86 случаях, что составило 0,04% к числу проведенных обследований (рисунок 5). Это превышает Европейский стандарт (0,01-0,02%). Наиболее высокий уровень выявления РШМ отмечается в Западно-Казахстанской (0,1%), Южно-Казахстанской (0,06%), Павлодарской (0,06%), Северо-Казахстанской (0,05%), Восточно-Казахстанской (0,05%) областях. В абсолютных цифрах наибольшее количество случаев отмечено в Южно-Казахстанской (23), Западно-Казахстанской (13), Карагандинской и Восточно-

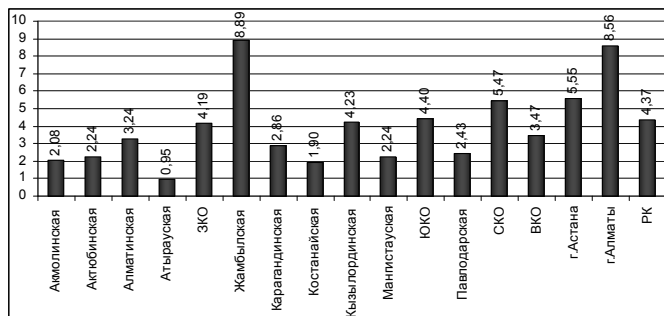


Рисунок 6. Процент больных с выявленной предопухоловой патологией шейки матки по результатам 6 месяцев 2011 года в разрезе по регионам.

Казахстанской (по 9 случаев) областях.

Предопухоловая патология выявлена у 10448 женщин, что составило 4,4% (рисунок 6). Наиболее чаще патология выявлялась в Жамбылской (8,9%) области и г.Алматы (8,6%), реже всего – в Атырауской (1%), Костанайской (1,9%), Акмолинской (2,1%), Мангистауской (2,2%) областях.

Из числа предопухоловой патологии следует выделить тяжелую дисплазию шейки матки (HSIL) – 2335 случаев (0,95%) и легкую дисплазию (LSIL) – 15083 случая (6,15%). Высокий уровень выявления HSIL отмечен в Северо-Казахстанской (8,6%) и Акмолинской (2,6%) областях, LSIL – также в Северо-Казахстанской (74,8%), Южно-Казахстанской (3,6%), Восточно-Казахстанской (3,2%), Павлодарской (3,2%) областях. В связи с высоким уровнем выявления дисплазии в Северо-Казахстанской области необходимо определить, не имеет ли место гипердиагностика.

Скрининг на раннее выявление предопухоловых и злокачественных новообразований толстой и прямой кишки.

Гемокульт-тест в основном проводился бензидиновой пробой, что не соответствует методике скрининга. Положительный результат гемокульт-теста отмечен в 5,4% случаях, что соответствует международным данным

(2-10%). Как представлено на рисунке 7, у каждого второго в Атырауской (304 из 635 – 47,9%), у каждого четвертого (27%) в Южно-Казахстанской, у каждого пятого (21,7%) в Акмолинской областях тест на скрытую кровь был положительным. Эти данные значительно превышают результаты зарубежных исследований и доказывают необходимость придерживаться рекомендуемой методики скрининга на раннее выявление колоректального рака с использованием иммунохимического теста (i-FOBT).

Колоректальный рак был выявлен только у одного пациента из Северо-Казахстанской области, еще у 17 была выявлена предопухоловая патология.

Обсуждение

С целью повышения эффективности профилактических

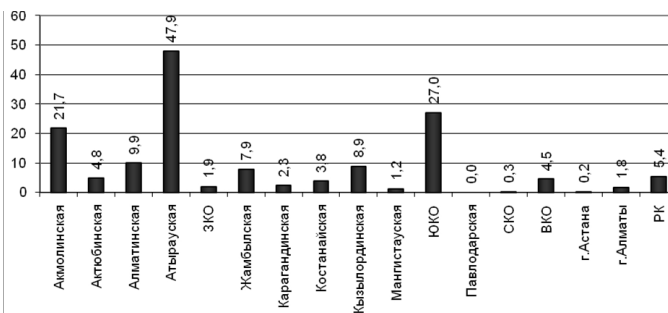


Рисунок 7. Процент пациентов с положительным гемокультур-тестом по результатам 6 месяцев 2011 года в разрезе по регионам.

медицинских осмотров (скринингов) была совершенствована нормативно-правовая база: приняты приказы МЗ РК от 5 января 2011 года № 7 «Об утверждении Положения о деятельности организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь», от 5 января 2011 года № 10 «О внесении изменений и дополнений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 апреля 2010 года № 238 «Об утверждении типовых штатов и штатных нормативов организаций здравоохранения», от 16 марта 2011 года № 145 «О внесении изменений в приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 10 ноября 2009 года № 685 «Об утверждении Правил проведения профилактических медицинских осмотров целевых групп населения» и другие. Согласно приказа МЗ РК от 1 марта 2011 года № 107 «О проведении выездных республиканских семинаров для специалистов первичной медико-санитарной помощи» было проведено 5 республиканских семинаров с общим охватом 1080 специалистов ПМСП, онкологической службы, специалистов ФЗОЖ с распространением раздаточных материалов. В дальнейшем на местах были проведены кустовые семинары для врачей, средних медицинских работников ПМСП. В сентябре 2011 года рамках консорциума АГИУВ-НИИ было подготовлено 120 преподавателей медицинских ВУЗов страны для дальнейшего каскадного обучения работников ПМСП по внедрению скрининговых обследований, повышению онконастороженности и раннему выявлению визуальных локализаций злокачественных новообразований на уровне.

Во всех регионах приказами Управлений здравоохранения были созданы Рабочие группы по мониторингу скрининговых осмотров. Управлениями здравоохранения, руководителями организаций ПМСП была проведена работа по обеспечению оборудованием и расходными материалами, формированию новых структурных подразделений согласно приказу МЗ РК от 5 января 2011 года № 7 и т.д.

Была проведена определенная работа по повы-

шению информированности населения о проводимых профилактических медицинских осмотрах, а именно: на сайтах управлений здравоохранения, центров формирования здорового образа жизни размещена информация «Минздрав предупреждает: позаботьтесь о своем здоровье – пройдите профосмотр», подготовлен и растиражирован информационно-образовательный материал для населения, в том числе адресное уведомление о необходимости прохождения скрининговых осмотров, в организациях ПМСП у входа и в местах ожидания пациентов установлены стенды с информацией о скрининговых осмотрах. В регионах созданы и утверждены медиа-планы об освещении процесса реализации Национальной скрининговой программы с запланированными выступлениями различных специалистов на местных радио и телеканалах, в печатных СМИ. Совместно со службой ФЗОЖ принимаются меры по повышению мотивации и вовлечению работодателей в прохождение скрининговых осмотров их сотрудниками.

По результатам проведенных скрининговых осмотров за 6 месяцев 2011 года выявлен целый ряд нерешенных проблем как по организационным вопросам, так по внедрению и качеству проведения скринингов.

По оснащению:

1. Острая нехватка маммографов в Алматинской (3), Карагандинской (2), Костанайской (1), Северо-Казахстанской (2) областях, устаревание и нехватка маммографов в Восточно-Казахстанской области (4). Требуют ремонта 1 маммограф в Алматинской (г.Талдыкорган), Восточно-Казахстанской (г.Риддер) областях.

2. Отсутствие передвижного маммографа в Кызылординской области.

3. Не все передвижные медицинские комплексы оборудованы маммографами, вследствие чего имеют место трудности с проведением маммографического скрининга в отдаленных сельских населенных пунктах.

4. Проблема с техническим обслуживанием маммографов в регионах РК.

5. Необходимо установить цифровые маммографы с цифровыми стереотаксическими приставками в онкологических диспансерах станы (19) для проведения уточненной диагностики и выявления малых форм РМЖ.

6. Отсутствие автоматов для окраски по методу Папаниколау в Атырауской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Мангистауской областях, г.Астана и Алматы.

7. Недостаточная обеспеченность цитологических лабораторий реактивами для проведения PAP-тестов.

8. Поздний закуп гемокульт-тестов. Практически все регионы используют бензидиновую пробу вместо иммуноферментного iFOBT теста, что противоречит методологии скрининга и оказывает существенное влияние на результаты колоректального скрининга.

10. Недостаточная обеспеченность организаций ПМСП ректоскопами.

11. Недостаточная обеспеченность организаций ПМСП колоноскопами и отсутствие видеоскопических стоек с колоноскопами в онкологических диспансерах.

12. Недостаточная обеспеченность организаций ПМСП аппаратами для экспресс-диагностики уровня холестерина крови, сахара крови, а также расходными материалами (полосками для аппаратов экспресс-диагностики).

По кадровому обеспечению:

Отсутствие отдельно выделенных штатов рентгенологов для проведения «вторых читок» в онкологических диспансерах.

Отсутствие отдельно выделенных штатов врачей-цитологов, цитотехников для проведения цитологического скрининга в онкологических диспансерах.

Недоукомплектование и неполное приведение в соответствие с приказом МЗ РК от 5 января 2011 года № 7 штатов и структуры ПМСП в части создания отделений профилактики и социально-психологической помощи с выделение достаточного количества ставок медицинского персонала (второй/третьей медсестры, для доврачебного кабинета и т.д.), участвующего в скрининговых осмотрах.

Недостаточная подготовка медицинских работников ПМСП по внедрению скрининговых осмотров, например, по методике опроса, что отражается на результатах распространенности поведенческих факторов риска, других результатах скрининговых осмотров.

Рекомендации

1. Проводить дальнейшее обучение специалистов ПМСП по проведению скрининговых осмотров, в том числе среди средних медицинских работников, руководителей отделений профилактики и социально-психологической помощи, а также врачебного персонала ПМСП, вовлеченного в скрининг.

2. Проводить обучение медицинских работников специализированных служб (рентгенологов, цитологов, офтальмологов, кардиологов, эндокринологов, акушер-гинекологов, маммологов, хирургов, проктологов) вопросам проведения скрининга.

3. Осуществлять работу по повышению информированности и мотивации населения, работодателей, других представителей гражданского общества о необходимости прохождения скрининговых осмотров.

4. Управлениям здравоохранения областей, г.Астана, Алматы:

4.1. решить в кратчайшие сроки проблемы по кадровому, структурному и материально-техническому оснащению организаций ПМСП, специализированных служб для реализации приказов МЗ РК по проведению профилактических медицинских осмотров;

4.2. определить количественные показатели целевых групп населения, подлежащих скрининговым осмотрам;

4.3. возложить на руководителей организаций ПМСП ответственность за передачу в РИАЦ проверенной базы данных о прошедших скрининговый осмотр пациентов, прикрепленных к данному ЛПУ.

5. ТОО «Мединформ»: сформировать и обеспечить территориальные РИАЦ программным обеспечением по обработке результатов скрининговых осмотров в соответствии с рекомендациями Рабочей группы по научно-методическому сопровождению профилактических медицинских осмотров.

6. Рабочей группе по научно-методическому сопровождению профилактических медицинских осмотров: организовать выезды в регионы для мониторинга организации и проведения скрининговых осмотров на местах с разработкой дальнейших предложений по совершенствованию скрининговых осмотров.